



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA EL MANEJO Y CUIDADO DEL ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS – CATÉTER

1. ALCANCE.

Inicia aplicando las medidas precautorias y realizando higiene de manos, finaliza con la desinstalación del equipo de la maquina de hemodiálisis.

2. MATERIAL Y EQUIPO

Describe el material y equipo necesarios para la realización de la actividad en mención.

- Material
 - Mesa de trabajo
 - Material de curación para catéter
 - a) Equipo conexión
 - Guante estéril (2 pares)
 - Campo estéril desechable
 - Jeringa 3 ml (2pzas)
 - Gasa de 7.5 cm x 5cm (9 pzas)
 - Apósito hypafix estéril
 - b) Equipo desconexión
 - Gasa de 20cm x 10cm (1pza)
 - Gasa de 7.5cm x 5cm (4pzas)
 - Tapón de rosca estéril desechable (2 pzas)
 - Guante estéril (2 pares)
 - Paquete gasa mediana estéril 10cm x 10cm
 - Jeringa 20 ml (2pzas)
 - Jeringas 10ml (2pzas)
 - Jeringa 5ml (2pzas)
 - Cinta adherible micropoore
 - Soluciones antisépticas en vasos estériles
 - Alcohol isopropilico 70%
 - Microdacyn
 - Apósito hypafix
 - guantes crudos (4 pzas)
 - Heparina 5000 UI/10ML Fco



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA EL MANEJO Y CUIDADO DEL ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS – CATÉTER

3. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
5.1	Enfermería	Realiza “IT-UV-01 Higiene de manos con agua y jabón”, y realizar “IT-JE-18 Manejo de medidas precautorias para el personal de hemodiálisis”.
5.2	Enfermería	Instala al paciente en camilla o reposet asignado y realiza monitoreo de constantes vitales. “IT-JE-39 Admisión, ingreso y egreso del usuario hospitalizado a la unidad de hemodiálisis” “IT-JE-40 Admisión, ingreso y egreso del usuario externo a la unidad de hemodiálisis” Secretaría de salud (2018) Manual para el cuidado estandarizado de enfermería a la persona con acceso vascular para hemodiálisis en el sistema nacional de salud http://www.cpe.salud.gob.mx/site3/programa/docs/manual_terapia_infusion.pdf
5.3	Enfermería	Verifica que el área se encuentre cerrada y evita corrientes de aire.
5.4	Enfermería	Prepara la mesa de trabajo y sanitiza con antiséptico (surfa safe) antes y después de procedimientos, coloca material necesario para realizar procedimiento.
5.5	Enfermería	Realiza lavado de manos.
5.6	Enfermería	Pide al paciente descubrir el sitio donde se encuentra el acceso vascular a manejar e inicia procedimientos.
5.7	Enfermería	Calza un par de guantes crudos para el retiro del apósito que cubre el catéter (sin retirar la gasa que cubre los lúmenes), desprende suavemente y desecha a basura común o a RPBI, según corresponda. No utilizar alcohol para la remoción del apósito previo. “PR-JE-08 Manejo de residuos peligrosos biológicos infecciosos”
5.8	Enfermería	Observa datos de infección: enrojecimiento, calor,

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA EL MANEJO Y CUIDADO DEL ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS – CATÉTER

		dolor, secreción purulenta, si observa datos de infección, registrar y notificar siempre al médico tratante antes de comenzar hemodiálisis.
5.9	Enfermería	Retira guantes crudos y los desecha al tiempo que revisa y observa el sitio de inserción, realiza técnica de higiene de manos con gel o solución alcoholada.
5.10	Enfermería	Abre el equipo de material estéril para curación, únicamente del extremo que contiene el material para la conexión, dejando intacto el extremo con material para desconexión, abre y deposita en el apartado de conexión las dos jeringas de 20ml y la gasa mediana estéril, sin contaminar.
5.11	Enfermería	Coloca un guante estéril en la mano dominante y prepara el material para realizar curación.
5.12	Enfermería	Vierte tres gasas 7.5 x 5cm de alcohol isopropílico, toma una gasa y realiza asepsia a partir del sitio de inserción del catéter a la periferia en forma circular, en un radio de 7 a 10cm, completando tres tiempos, uno por cada gasa y permite que el alcohol actúe.
5.13	Enfermería	Vierte tres gasas 7.5 x 5cm de antiséptico (Microdacyn), toma una gasa y realiza asepsia a partir del sitio de inserción del catéter a la periferia en forma circular, en un radio de 7 a 10cm, completando tres tiempos y deja actuar el antiséptico.
5.14	Enfermería	Retira el exceso de antiséptico con gasa estéril 7.5 x 5cm seca, deje secar antiséptico y cubre sitio de inserción con dos gasas estériles de 10 x 10 por debajo y encima del lumen, evitando que este tenga contacto con piel y a su vez con el apósito adherible, para después cubrir con apósito hypafix, evitando estirarlo y dejar burbujas.
5.15	Enfermería	Retira gasa que cubre los lúmenes.
5.16	Enfermería	Retira guante y realiza higiene de manos.
5.17	Enfermería	Se coloca un guante del segundo par de guantes estériles.
5.18	Enfermería	Verter alcohol isopropílico en dos gasas estériles 7.5 x 5cm, tomando las extensiones del catéter con una



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA EL MANEJO Y CUIDADO DEL ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS – CATÉTER

		gasa seca con la mano no dominante.
5.19	Enfermería	Coloca el campo estéril en el paciente por debajo de los lúmenes, para aislar las extensiones o lúmenes.
5.20	Enfermería	Se coloca el otro guante.
5.21	Enfermería	Toma una de las gasas con alcohol y limpia de forma rotatoria cada uno de los extremos distales por 60 segundos y retira los tapones, luego, desecha gasa y tapones.
5.22	Enfermería	Toma la segunda gasa impregnada con alcohol y limpia perfectamente la conexión luer lock con fricción por 60 segundos, de manera que se retire cualquier residuo de la conexión anterior.
5.23	Enfermería	Conecta una de las jeringas de 3ml en el puerto arterial, abre clamp, succiona sello de heparina, cierra clamp y desecha la jeringa, repete con la segunda jeringa en el puerto venoso
5.24	Enfermería	Toma una jeringa de 20 ml y comprueba la integridad y permeabilidad del lumen arterial y deja conectada al lumen la jeringa, toma la segunda jeringa de 20 ml y repite la acción con el lumen venoso.
5.25	Enfermería	Observa si existen datos de mal funcionamiento como: disfunción del acceso vascular, bajo flujo o efecto válvula, notificar al médico y esperar nuevas indicaciones. Si no hay datos de disfunción continuar procedimiento.
5.26	Enfermería	Realiza la conexión firme de los lúmenes a las líneas del circuito extracorpóreo, toma una gasa estéril de 10 x 10cm y envuelve la unión y fija con cinta adherible al paciente y a su vez envuelve con el campo ambos lúmenes fijando con cinta micropore.
5.27	Enfermería	Procede al inicio del tratamiento de hemodiálisis por el tiempo prescrito, y considerando el estado hemodinámico del paciente, al detectar cualquier alteración, notificar de inmediato al médico tratante. "IT-JE-26 Intervención de enfermería en el tratamiento de hemodiálisis"

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA EL MANEJO Y CUIDADO DEL ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS – CATÉTER

		DESCONECCIÓN
5.28	Enfermería	Finalizada la terapia de hemodiálisis, notifica al usuario que se procederá a la desconexión, realiza el retorno sanguíneo del circuito extracorpóreo con solución salina al 0.9% en circuito cerrado y cierra los clamps, verificando que no existan corrientes de aire antes de la desconexión.
5.29	Enfermería	Realiza higiene de manos "IT-UV-01 Higiene de manos con agua y jabón", abre el equipo de desconexión estéril, abre dos jeringas de 10ml y las carga con solución salina al 0.9% y abre 2 jeringas de 5 ml y las carga con anticoagulante de acuerdo a la prescripción médica.
5.30	Enfermería	Calza un guante en la mano dominante y vierte en dos gasas de 7.5 x 5cm alcohol isopropílico, con una gasa limpia a modo de fricción en ambas extensiones del catéter, ramales, puntos de unión y líneas, para proceder a desconectar circuito.
5.31	Enfermería	Toma una gasa seca para cubrir las extensiones y protegerlas de ser expuestas al medio ambiente, con la segunda gasa alcoholada retira cualquier resto hemático de la conexión luer lock.
5.32	Enfermería	Lava cada extensión del catéter con la solución salina de las jeringas de 10ml y aplica la heparina con las jeringas de 5cc según se indique en cada extensión del catéter.
5.33	Enfermería	Pinza inmediatamente clamps, colocando los tapones luer a cada ramal, cubriéndolos con gasa de 10x 10 estéril.
5.34	Enfermería	Coloca apósito hypafix, sin presionar o estirar sobre la piel, y siendo este apósito uno diferente e independiente al apósito de la parte superior del catéter.
5.35	Enfermería	Realiza higiene de manos con solución alcoholada, se calza guantes crudos y procede a la desinstalación del



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA EL MANEJO Y CUIDADO DEL ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS – CATÉTER

		equipo monitor de hemodiálisis.
5.36	Enfermería	Observaciones • Evitar siempre colocar apósito adherible hypafix sobre extensiones del catéter para reducir adherencias de pegamento, esporas o pelusas. • Los mililitros de heparina utilizados son de acuerdo a la prescripción de la extensión de cada lumen del catéter y las unidades, a la indicación médica.

4. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. Acceso vascular con problemas de permeabilidad.	a. Comprobar permeabilidad de las líneas previo a la conexión. b. Lavado eficiente de líneas al realizar desconexión. c. Sellar el catéter con dilución de heparina indicada.
b. Acceso vascular con datos de infección.	d. Mantener técnica de barrera máxima al manipular las líneas. e. Uso de antisépticos adecuados y limpieza eficiente de conectores.
c. Desconexión accidental de las líneas hemáticas.	f. Fijación correcta de los lúmenes del catéter durante la sesión de hemodiálisis.
d. Salida accidental del catéter.	g. Desprendimiento seguro del apósito. h. Verificar fijación del catéter a la piel. i. No dejar traccionada la línea del catéter durante la sesión.

5. ANEXOS.

5.1 Documentos de referencia.



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA EL MANEJO Y CUIDADO DEL ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS – CATÉTER

5. ANEXOS.

5.1 Documentos de referencia.

Nombre del documento	Código
Secretaría de salud (2018) Manual para el cuidado estandarizado de enfermería a la persona con acceso vascular para hemodiálisis en el sistema nacional de salud http://www.cpe.salud.gob.mx/site3/programa/docs/manual_terapia_infusion.pdf	No aplica
Higiene de manos con agua y jabón	IT-UV-01
Manejo de medidas precautorias	IT-JE-18
Intervención de enfermería en el tratamiento de hemodiálisis	IT-JE-26
Admisión, ingreso y egreso del usuario hospitalizado a la unidad de hemodiálisis	IT-JE-39
Admisión, ingreso y egreso del usuario externo a la unidad de hemodiálisis	IT-JE-40
Manejo de residuos peligrosos biológicos infecciosos	PR-JE-08



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA EL MANEJO Y CUIDADO DEL ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS – CATÉTER

6. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
01	Julio 2021	Alta de documento	Toledo Casas Gerardo	Ana Cecilia Zarate Bautista
02	Agosto 2024	Actualización de documento	Mendoza Garcia Mayda Guadalupe	Ana Cecilia Zarate Bautista
03	Septiembre 2025	Actualización de documento	Mendoza Garcia Mayda Guadalupe	Juan Carlos Vanegas Reyes

7. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Lic. Juan Carlos Vanegas Reyes	 Dra. Giselle Ivette De la Torre García	 Hna. María de Jesús García Castro
Jefatura de enfermería	Jefatura de Calidad	Dirección General